

NOTULEN

HARI & TANGGAL : SENIN, 12 JANUARI 2026
 PUKUL : 08.00 WIB – 16.00 WIB
 AGENDA RAPAT : RAPAT PRA RAKER

PEMIMPIN RAPAT : dr. SADI HARIONO, M.MRS
 NOTULIS : ADINDA LESTARI PUTRI, S.KM
 TEMPAT : HALL SAKURA LANTAI 5

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Sambutan dr. Sadi Hariono, M.MRS	Optimalisasi dan Pengembangan Rumah Sakit	1. Rumah sakit perlu untuk selalu evaluasi dan perbaiki sistem mengikuti perkembangan 2. Take over Rumah Sakit dengan sistem baru disesuaikan dengan kondisi lingkungan	Direksi PT & Manajemen RS
2.	Sambutan dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE	Pengembangan berbasis efisiensi	1. Direktur dapat memberikan input dan masukan terhadap program program dari rumah sakit. 2. Program 2026 efisiensi tetap dijalankan tetapi berfokus pada pengembangan 3. Rumah sakit dapat lebih agresive dalam melakukan pengembangan	Direksi PT & Manajemen RS
3.	RS Dharma Husada Probolinggo	Strategi marketing RSDH belum berbeda dan optimal melalui rujukan	Menyusun strategi marketing berbasis rujukan serta regulasi fee & CN sesuai ketentuan	Manajemen RS Marketing
		Jumlah DPJP masih kurang	Evaluasi kebutuhan dan rencana penambahan DPJP sesuai layanan prioritas	Direksi RS & SDM
		Rencana pembangunan gedung baru dan pembongkaran eks apotek	Menyusun master plan pembangunan dan timeline relokasi layanan	Direksi RS & Sarpras & Direksi PT
		Pemanfaatan kelas KRIS belum optimal	Maksimalisasi 4 TT per kamar untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur	Manajemen RS & Sarpras

		Kebutuhan peningkatan kompetensi ICU	Mengirim staf ICU mengikuti pelatihan & sekolah ICU bisa di ambil dari staf lama maupun staf baru	SDM & Keperawatan
		Kunjungan Direksi PT belum terjadwal rutin di seluruh unit usaha	Menyusun jadwal kunjungan Direksi PT secara berkala	Direksi PT & Sekretariat
		Produktivitas IRJA belum seimbang antara pemasukan dan biaya	Analisis pendapatan dan beban operasional IRJA Strategi marketing dan implementasi sistem fee perujuk	Manajemen RS & Keuangan
		Evaluasi kepuasan staf belum jelas apakah sudah termasuk DPJP	Diskusi lebih lanjut dengan SDM PT terkait cakupan survey kepuasan untuk dapat diukur termasuk DPJP dan dilaporkan hasilnya ke PT untuk tindak lanjut	SDM RS, SDM PT dan Direksi PT
		Audit dokter IGD	Diskusi hasil audit dengan para direktur untuk perbaikan layanan	Direksi RS & Komite Medik
		Penilaian kepuasan pasien belum terfokus	Menentukan penilai dan mengerucutkan survei per unit sehingga dapat di amati dan evaluasi lebih detail	PMKP & Manajemen RS
		Kemandirian staf masih kurang	Evaluasi kinerja dilakukan bersama Komite Keperawatan dan Kepala Bidang dengan penetapan target kemandirian staf. Ketidaktercapaian target akan ditindaklanjuti melalui evaluasi kinerja dan dapat dikenakan pemotongan gaji atau bentuk punishment lainnya sesuai regulasi internal rumah sakit.	SDM & Komkep & Kabid
		Pemilihan peserta diklat belum berbasis kompetensi	Hasil evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan staf yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), sehingga staf yang dipilih merupakan staf yang kompeten	SDM & Kepala Unit

		Pelatihan PMKP belum terpusat	Diskusi sentralisasi pelatihan PMKP di tingkat PT	PMKP PT & Direksi RS
		Efisiensi biaya dan kontrol cashflow	Menyusun strategi efisiensi proses bisnis dan kontrol pendapatan cash	Direksi RS & Keuangan
		Indikator penilaian BPJS dapat dijadikan penilaian kinerja Direktur RS	Setiap bulan Rumah Sakit wajib menyampaikan hasil indikator penilaian BPJS kepada PT. Capaian setiap indikator tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja Direktur Rumah Sakit oleh Direktur PT.	Direksi RS dan Direksi PT
		Hasil survey belum ditindaklanjuti optimal	Perbaiki berkelanjutan atas hasil survei perlu di monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	PMKP & Manajemen RS
4.	RS PRIMA HUSADA SUKOREJO	Kepuasan pasien perlu ditingkatkan agar kebijakan baru tidak mempengaruhi pangsa pasar	Meningkatkan mutu pelayanan dan komunikasi kebijakan agar kepuasan pasien tetap terjaga	Manajemen RS & PMKP
		Monitoring kepuasan pasien belum berbasis unit	Menyusun survei kepuasan berbasis unit untuk monitoring dan evaluasi lebih detail	PMKP & Kepala Unit
		Pembinaan K3 dan Dapur belum optimal untuk menarik perusahaan	Penguatan pembinaan K3 dan Dapur sebagai daya tarik marketing ke perusahaan	K3 RS & IPSRS & Marketing
		Evaluasi IGD belum terdokumentasi terstruktur	Melaksanakan evaluasi IGD harian melalui daily report dengan melibatkan Kains IGD	Manajemen RS & Kains IGD
		Kegiatan mutu dan studi kasus masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan pelaksanaan program mutu dan pembahasan studi kasus secara rutin	PMKP & Komite Medik
		Ancaman terbesar berasal dari SDM berdasarkan survei kepuasan staf	Evaluasi manajemen dan tindak lanjut hasil survei kepuasan staf Analisa mengapa staf yang mengisi survey semakin turun	SDM & Direksi RS

			Membuat alur pelaporan / pengaduan staff yang menjamin keamanan dan kerahasiaan	
		Piutang belum tertangani optimal	Membentuk tim adhoc khusus penanganan piutang	Keuangan & Direksi RS
		Strategi marketing MCU berisiko kalah tender	Melakukan promosi MCU dengan margin minimal untuk menarik pangsa pasar Prinsip tidak boleh kalah tender	Marketing & Keuangan
		Pelayanan awal IGD belum optimal	Menerapkan pelayanan IGD yang cepat, tepat, dan akurat dengan backup manajemen	Manajemen RS & IGD
		RS belum memiliki analisis komprehensif saat terjadi penurunan pasien	Menyusun mekanisme analisis akar masalah saat terjadi penurunan kunjungan pasien	Manajemen RS & PMKP
5.	SURVEY KEPUASAN	Survey kepuasan DPJP	Buat survey kepuasan DPJP untuk bisa menampung kritik saran DPJP terhadap kinerja staff, manajemen RS, sarpras, dsb	Manajemen RS
6.	RS PRIMA HUSADA MALANG	Upaya mempertahankan pasien lama dan meningkatkan pasien baru belum terstruktur	Di era PRB, harus lebih gencar mencari pasien baru. Strategi marketing dan penguatan MCU	Manajemen RS & Marketing
		Potensi miss komunikasi di tahun 2026, khususnya di IGD	Menetapkan mekanisme pencegahan miss komunikasi, termasuk opsi evaluator khusus di IGD Pelatihan skill komunikasi Alur pengaduan staff ke manajemen yang menjamin kerahasiaan dan keamanan	Manajemen RS
7.	Evaluasi Klaim BPJS	PPK CP RS minimal 5 belum masuk INM	Menetapkan minimal 5 PPK CP RS untuk didaftarkan ke INM	Komite Medik & Manajemen RS

		Manajemen risiko klaim belum sesuai kriteria	Memasukkan manajemen risiko klaim sesuai kriteria BPJS	Manajemen RS & Asuransi Center
		Belum ada target bulanan klaim BPJS	Menetapkan dan menyampaikan target bulanan klaim BPJS dalam setiap agenda laporan bulanan	Asuransi Center & Direksi
		Belum ada program kerja Asuransi Center 2026	Menyusun program kerja dan indikator rawat inap Asuransi Center 2026	Asuransi Center & Direksi
		Target Klaim Rumah Sakit	Menurunkan klaim pending RJ < 0,5% dan RI < 0,1%	Asuransi Center
			Menargetkan klaim tidak layak sebesar 0 Rupiah	Asuransi Center & Manajemen
			Mengendalikan audit pasca klaim ≤ Rp1.000.000	Asuransi Center & Manajemen
			Mengendalikan audit pasca klaim RI pada kisaran Rp1–2 juta	Asuransi Center & Manajemen
			Identifikasi bulanan dari sisi peserta, klinis, dan keuangan	Asuransi Center & Manajemen
		Istilah SEP approval masih digunakan	Menghilangkan penggunaan istilah SEP approval	Manajemen RS
		Selisih klaim masih tinggi	Mengendalikan selisih klaim sesuai indikator mutu RJ & RI	Manajemen RS & Asuransi Center
		Risiko pelayanan HD & CKD Stage 5 yang dihubungkan dengan episode pelayanan	Pengetatan persyaratan pelayanan HD harus di koordinasikan dengan konsultan BPJS PT dan dikumpulkan 1 hari sebelum Agenda Raker	Asuransi Center, Manajemen RS & DPJP PHS
		Pemahaman episode perawatan & PPK belum merata	Diklat internal 2x/minggu terkoordinasi dengan SDM tentang episode perawatan, aturan klinis tentang PNPK dan BA Kesepakatan	SDM, Manajemen RS & Asuransi Center

	PPK CP belum terhubung kendali mutu & biaya	Diskusi dengan dr. As terkait PPK CP KMKB	Komite Medik
	Pemahaman PRB & Iterasi antar RS berbeda	Penyamaan persepsi PRB & Iterasi antar RS	Manajemen RS
	8 indikator BPJS belum masuk indikator mutu unit	Memasukkan 8 indikator BPJS ke indikator mutu unit	PMKP
	Dokumentasi klinis DPJP belum optimal	Pendidikan DPJP terkait dokumentasi klinis	Komite Medik
	Belum ada program kerja DPJP 2026	Menyusun program kerja DPJP tahun 2026	Direksi RS
	Pemahaman mengenai Audit BPJS di RS	Audit di RS sesuai dengan perpres nomor 82 tahun 2018 - Audit Pasca Klaim - Audit Administrasi - Audit - Audit TPKMKB	Manajemen RS
	Unit pelayanan belum sepenuhnya memahami KMKB & klaim	Melibatkan seluruh unit terkait klaim dalam diklat	SDM & Asuransi Center
	PPK CP belum ada yang di kirimkan ke PT DPM	Pengumpulan PPK CP 3 RS sebagai panduan diklat & klaim. Maksimal Jumat, 23 Januari 2026. Pembuatan PPK berkoordinasi dengan Konsultan BPJS PT Disa Prima Medika dan DPJP	Komite Medik, Konsultan PT dan Manajemen RS
	PPK CP belum jadi indikator rekrut DPJP	Menjadikan PPK CP indikator rekrut DPJP & bisa di masukkan juga kedalam e-RM	SDM & IT

		Belum ada tim rujukan PPK CP	Membentuk tim rujukan PPK CP untuk kasus khusus yang belum dijelaskan dalam PPK CP. Setelah membuat PPK CP dilanjutkan menyusun BA kesepakatan penegakan diagnosis	Komite Medik dan Manajemen RS
		Tim PPK CP belum aktif	Mengaktifkan kembali tim PPK CP & diskusi aktif dengan DPJP	Direksi RS dan Komite Medik
		PPK CP belum dikonsultasikan	Diskusi PPK CP dengan Pak Puguh	Manajemen RS
8.	Identifikasi Masalah Prioritas	Program HD belum diatur jelas untuk dokter umum	Menyusun dan mengatur program HD yang terstruktur bagi dokter spesialis dan dokter umum (kurang lebih sama)	Manajemen RS & Komite Medik
		Masa jabatan staf belum diidentifikasi untuk pengelolaan beban kerja dan loyalitas	Melakukan identifikasi masa jabatan serta diskusi skema penghargaan bagi staf loyal	SDM & Manajemen RS
		Target SKP tahunan pegawai belum terukur	Menetapkan target SKP tahunan (biaya pribadi) yang terukur sebagai indikator peningkatan kompetensi staf	SDM & Atasan Langsung
		Proporsi beban gaji tenaga kesehatan dan non kesehatan perlu analisis lebih dalam	Identifikasi dan evaluasi persentase beban gaji tenaga kesehatan dan non-kesehatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan karakter rumah sakit yang berfokus pada pelayanan kesehatan, dimana proporsi beban gaji tenaga kesehatan seharusnya lebih dominan.	Keuangan & SDM
		Penilaian kualifikasi jabatan belum berbasis sertifikat kompetensi	Menilai kualifikasi jabatan berdasarkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman manajemen SDM	SDM & Manajemen RS
		Program kerja SDM belum optimal dalam peningkatan kualitas dan kuantitas	Melengkapi dan menyempurnakan program kerja SDM untuk peningkatan kualitas dan kuantitas	SDM PT, SDM RS, Direksi RS dan Direksi PT

			SDM yang akan di bahas lebih lanjut dalam sesi khusus SDM Survey kepuasan staff	
		Analisis fishbone belum spesifik dan belum mengerucut pada masalah utama	Menyusun analisis fishbone yang lebih spesifik dan terfokus pada akar permasalahan. Pilih masalah yg spesifik dan mengerucut bukan general	Manajemen RS
9.	FGD	Pembagian kelompok dan materi	Terlampir	Tim FGD

Pemimpin Rapat



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Malang, 12 Januari 2026

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Adinda Lestari Putri, S.KM

PEMBAGIAN KELOMPOK FGD

NO	NAMA KELOMPOK	MATERI	OUTPUT	PEMBAHASAN
1.	1. drg. Endy Wira Pradana, MMRS 2. Ayu Bintang Tinara, Amd.Rad 3. Dwi Novianti, Amd.AK., S.Kes 4. Wulandari 5. Sindy Novenia, S.Pd., M.Ak 6. Sinta Luckyedi, S.Psi., CHCM	Efisiensi: ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya	1. Mampu mengidentifikasi proses / pemebelanjaan yang masih belum efisien 2. Inovasi perbaikan alur / proses kerja / pembelanjaan agar tercapai efisiensi	1. Area mana yang paling tidak efisien dan paling berdampak terhadap kinerja rumah sakit? 2. Di mana potensi kebocoran biaya yang paling sering terjadi? 3. Prosedur apa yang bisa disederhanakan tanpa menurunkan mutu dan keselamatan pasien? 4. Proses manual apa saja yang paling mendesak untuk digitalisasi? 5. Inovasi apa saja yang pernah dicoba dan terbukti meningkatkan efisiensi? 6. Indikator apa yang sebaiknya digunakan untuk memantau efisiensi berkelanjutan? 7. Cari data dari layanan yang ada di RS dan pilih paling tidak efisien dan kaji mulai dari klinis, medis maupun keuangan 8. Bagaimana strategi pengendalian dengan corcontainment 9. Analisa juga dari segi klinis dan manajerial
2.	1. dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS 2. dr. Tamara Aulia Fakhriinnisa 3. Dini Dwi Oktaviana Amd. RMIK 4. Rhizqita Julian Eka Rahmanda, AMD. PK, SKM	Klaim Paripurna	1. Mampu mengidentifikasi penyebab klaim tidak paripurna	1. Di tahap mana proses klaim paling sering bermasalah? Pelayanan, Coding, Berkas, Verifikasi (diurutkan dari yang paling bermasalah – tidak bermasalah)

	5. Aditya Dwi Arimbi, S.Tr.Kes Nur Rizkiah Amalia 6. Nur Rizkiah Amalia		2. Memberikan usulan perbaikan dari setiap lini untuk mencapai klaim paripurna	2. Bagaimana mekanisme review mutu klinis sebelum pasien dipulangkan? 3. Item biaya apa yang paling sering menyebabkan klaim deficit? 4. Usulan penetapan indicator mutu yang berkaitan dengan klaim? 5. Intervensi apa yang paling berdampak untuk meningkatkan klaim diterima dengan sempurna? (tanpa pending/retur)
3.	1. Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep 2. Saniza Indra Putra Glassya, S.Psi 3. Susan Rahmawati, S.Sos 4. Novia Ainur Pratiwi, S.KM 5. Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM	Zero Complaint	1. Mampu mengidentifikasi faktor yang menimbulkan potensi adanya complain 2. Mengusulkan inovasi pencegahan eskalasi complain	1. Jenis complain apa yang paling sering muncul? (asuhan medis, komunikasi petugas, waktu tunggu, attitude) 2. Informasi apa yang paling sering tidak dipahami pasien sehingga berujung complain? 3. Bagaimana kecepatan respons terhadap keluhan pasien? Yang ideal response time berapa lama? 4. Bagaimana cara memaksimalkan peran perawat dalam sistem early complaint detection dan sebagai front liner dalam mencegah eskalasi complain? 5. Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seluruh staff dalam menghadapi pasien/keluarga yang emosional/agresif? 6. Inovasi apa yang efektif menurunkan complain di unit?

4.	1. dr. Resti Lestantini, M.Kes 2. Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns 3. Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb 4. dr. Dyan Santi Palupi 5. Sisca Puspitasari, S.Kep., Ns	Pelayanan Medis sesuai PNPK	Tercapainya Pelayanan medis yang berbasis EBM, mengacu standar nasional, menjamin mutu & keselamatan pasien, menjadi rujukan penyusunan PPK, CP, SOP	1. Apakah PNPK sudah menjadi acuan utama atau masih dianggap sebagai dokumen regulasi? 2. Bentuk adaptasi PNPK terhadap pelayanan medis sehari-hari? 3. Tahap pelayanan medis mana yang paling sering tidak sesuai dengan PNPK? 4. Faktor apa saja yang paling sering menyebabkan penyimpangan terhadap PNPK? (kondisi pasien, sarpras, asuhan DPJP, dll) 5. Bagaimana pengambilan Keputusan klinis saat kondisi pasien tidak sesuai algoritma PNPK? 6. Hambatan utama dalam penerapan PNPK di rumah sakit masing-masing? 7. Langkah prioritas yang harus dilakukan untuk memastikan PNPK menjadi <i>clinical culture</i>?
----	--	-----------------------------	---	--

LAMPIRAN DOKUMENTASI

